

QUELQUES NOTIONS GENERALES

I. Motif de consultation

1. Douleur au niveau FID : suspicion **appendicite**.

Localisation +++ (examen clinique).

Rechercher : fièvre, vomissements, transit (diarrhée / constipation / conserver), dernier angine / covidé .., prise un trt antérieure, parasitose.

Demander : échographie avec doppler, bilan complet.

Puis : scorer le malade +++.

2. Douleur abdominale + vomissements + transit non conservé + cri incessant = suspicion **occlusion intestinale** chez un nourissant (surtout ++) → interrogatoire + demander échographie avec doppler.

3. AVP / chute :

- ASP
- Echographie abdominale pelvienne.
- Contrôle après 48 h.
- Avis CCI ++.

4. Hernie : ombilicale / inguinale.

II. Lettre d'échographie

Cher confrère,

Permettez-moi de vous adresser l'enfant / nrs / nné sus nommé (e) sus âgé (e), sans ATCDs (si + ATCDs → citer + mentionner avec au sans trt). Qui présente (motif de consultation).

Je vous le confie pour une échographie (type : abdomino-pelvienne, inguino-scrotale ...) +/- doppler (pour une bonne visualisation de la vascularisation sanguine).

Cordialement, Confraternellement.

III. Autorisation de sortie

La garde malade : nom et prénom

Va sortir à (l'heure de sortie) et va remplacer par (nom et prénom de la personne qui la remplacer).

IV. Bilan complet

- FNS + groupage
- Glycémie
- Bilan rénal (urée/créat)
- Ionogramme sanguine (Na+/K+/Cl-)
- TP, TCK = bilan d'hémostase.
- CRP avec titrage

V. Remplir les dossiers

GRANDE ENVELOPPE :

- Dgc en haut + groupage
- Service CCI
- Nom, prénom, age, adresse.
- Entrée le : la date d'entrée
- Sortie le : la date de la sortie
- Numéro de téléphone :
- TP : temps patient = c'est l'heure d'arrivé – le temps de début des symptômes.
- HA : heure d'arrivé = c'est presque 30 mn à 1h, le temps qu'on a pris pour hospitaliser le

malade.

- TH : temps d'hospitalisation

CONTENU :

- Fiche de trt : vert ou blanc
- Fiche de dgc : orange
- Fiche de rendez-vous
- Echographie, TDM, ...
- Lettre d'orientation
- Bilans...

VI. Les tubes

→ Tube sec (rouge) :

- CRP
- TPHA : Treponema palladium : syphilis.
- ALAT (pour poser dgc d'une maladie hépatique spécifique : ↑ s'il y a une maladie)/ASAT (pour surveiller : foie + tube digestif)
- Ca²⁺
- HDL
- HIV
- Hbs
- HCV : hépatite C
- Rubéole
- Toxoplasmose
- Magnésémie
- Hépatite ABC
- Bilirubine
- Progestérone
- Phosphore

→ Tube vert : Héparine

- Urée/Créat
- Ionogramme
- Troponine
- Calcémie
- Glycémie
- TAP/TGP : glutamate pyruvate transaminase
- Ferritinémie
- PAL : phosphatase alcaline
- BI
- BD
- Acide urique
- Bilirubine

→ Tube violet : EDTA

- FNS
- HBC
- HCV
- HIV
- TPHA
- Groupage
- Frottis sanguin

→ **Tube bleu : Cirate**

- TP
- VS
- GS
- Fibrinogène
- TCK
- INR

MOTIFS DES CONSULTATIONS

• Abréviations

- QSP : quantité suffisant pour
- Flc : flacon
- Bte : boîte
- Ddp : dose du poids
- Sac : sachet
- Cp : comprimé
- Sus buv : suspicion buvable
- Cà m : cuillère à mesure

I. Vomissement

→ **Enf, Nné, NRS :**

Vomiteb sirop 1 ddp 3*/j → 1 flc

→ **>2ans :**

Domperidone sirop 1 ddp 3*/j → 1 flc

+ **RHD :**

- Adulte : boire bcp l'eau.
- Enf : **SRO** sachet saidal → 1 bte
1 sachet ds 1L d'eau bouillie refroidie
2 càs : 50cc après chaque vms.

II. Douleurs abdominales

- **Spasfon** → 1 bte
Petit enf : Lyoc , 1cp 3*/j
Grand enf : cp 80mg 1cp 3*/j
- **Debridat** → 1 bte
Petit enf : sirop enfant 1 flc, 1 cà m 3*/j
Grand enf : cp 100mg 1 bte, 1cp 3*/j.
- +/- **Bedelix** sachet 1 sachet 3*/j → 1 bte.
- Si douleur de FID → suspicion appendicite :
Avis CCI.

III. Diarrhée

- **Tiorfan** sachet 10mg → 1 bte
1 sachet 3*/j (> 3ans)
½ sachet 3*/j (< 3ans)
- **Smecta** sachet 10mg → 1 bte
½ sachet 3*/j Enf
1 sachet 3*/j Adulte 125 – 200mg
- **Flagyl** sirop 30mg/kg/j 1 cà m 2*/j → QSP 8j
(si glaire + fièvre).
- **SRO** sachet → 1 bte
1 sachet ds 1L d'eau bouillie et refroidie
après chaque selle.
Si < 2ans : 50cc.

IV. Constipation

- **Debridat** sirop 1 ddp 3*/j → 1 flc
→ Si enf > 12 ans :
- **Trimébutine** cp 1cp 2*/j → 1 bte
- **Duphalac** sirop → 1 flc
Forlax sirop < 1an : 1*/j

1 – 6ans : 1cc 2*/j

>6ans : 3*/j

- **Glycérine** suppo 1 -2 suppo/j → 1bte.

V. Brûlé

→ En fonction de profondeur :

- **1^{er} degré** : érythème douloureux, sans phlyctène.

- **2^{ème} degré** :

*Superficielle : phlyctène douloureuse

*profonde : blancheur, phlyctène de grand diamètre.

- **3^{ème} degré** : perte de sens, peau cartonnée.

→ **Agents** : thermiques +++, électriques, chimiques, radioactif...

→ **Conséquences** :

P1 : choc hypovolumique +
hémococoncentration =

P2 : réponse inflammatoire systémique.

→ **Signes de gravité** :

- SCB (surface corporelle brûlée) >
12 - 15% → adulte
20% → âgé/enf
10% → NRS

- Age : > 70ans / NRS

- Lésion / tares associées.

→ **SCB (enf +++)**

- Si < 10ans :

Tête : 9 + (10 – âge)

MI : 36 – (10 – âge)

- Tête + cou : 17 %
- Face ant du tronc : 18%
- Face post du tronc : 18%
- Chaque jambe : 14% (*2)
- Chaque bras : 9% (*2)
- Périné : 1%
- Total 100%

Règle de
9 de
Wallace

→ **Ordonnances des soins** :

- **Calcial** sirop 1càm/j → 1flc

- **Ferrostrane** sirop 1càm2*/j → 1flc

- **Atarax** sirop 2mg/ml 1càm/j le soir → 1flc

- **Mebo** pommade (pour la face) 1flc/
Flammazine (pour le reste du corp) (2^{ème} degré
superf).

- Tulle gras.

- Si sortie : + **Augmentin**.

→ **Si hospitalisation** : en IVL : SCB > 5%

- **Claforen** pds *100/3 → 3*/j

- **Flagyl** pds *30/3 → 3*/j

- **Perfalgol** pds *15 → 4*/j

- **Solumédrol** 1mg/kg → /j

- RDB 100cc/kg → /24

→ **Schéma de CARVAJAL**

(valable pour enf < 40kg).

J1 : 2000*SC + (5000 * SB).

J2 : 1500*SC + (4000 * SB).

J3 : 2200*SC + (2800 * SB).

$$\text{SC: } \frac{4p+7}{p+90}$$

$$\text{SB: } \frac{\text{Sc*estimation}}{100} = \text{SC} * \text{X\%}$$

SC : surface corporelle totale en m²

P : poids en kg.

SB : surface corporelle brulée en m²

X% : 0.X

→ **Albumine** : poids * 5 = Q

Dilution : 3Q * SG.

→ Pour l'**Augmentin** (à titre externe) :

Si > 40 kg = 50 mg/kg/j * 3/j.

V. Appendicite médicale

→ Si pas d'admission

1) **Oroken** sirop enf $1\text{ddp} \times 2/\text{j} \rightarrow \text{QSP } 15\text{j}$

Si **Claforan** $100\text{mg}/\text{kg}/\text{j } 4^*/\text{j}$

Augmentin $80\text{mg}/\text{kg}/\text{j}$

Oroken : $4\text{-}8\text{ mg}/\text{kg}/\text{j}$

$<10\text{kg}$: sirop $40\text{mg } 1\text{ddp} \times 2/\text{j}$

$10\text{-}40\text{kg}$: sirop $100\text{mg } 1\text{ddp} \times 2/\text{j}$

$>40\text{kg}$: cp $200\text{mg } 1\text{cp} \times 2/\text{j}$

2) **Flagyl** sirop enf $125\text{mg } 1\text{càm } 3^*/\text{j} \rightarrow \text{QSP } 7\text{j}$

$30\text{mg}/\text{kg}/\text{j}$ en 3 prises.

Si cp : $250 - 500\text{mg}$

3) **Doliprane** suppo $1\text{suppo}/6\text{h} \rightarrow 1\text{ bte}$

S'il y a une fièvre / une douleur

$< 8\text{kg}$: 100mg

$8\text{-}12\text{ kg}$: 150mg

$13\text{-}20\text{kg}$: 200mg

$>20\text{kg}$: 300mg

Cp: $500\text{mg} - 1000\text{mg}$

→ Si hospitalization

- **Claforan** : pds $\times 100/3$

- **Flagyl** : pds $\times 30/3$

- **Perfalgan** : pds $\times 15$

- **RDB** : $100\text{cc}/\text{kg}$

- **+/- Solumédrol** : $1\text{mg}/\text{kg}$

- **+/- Gentamycine** $8\text{mg} \times \text{inj IM}/\text{le soir QSP } 6\text{j}$.

VI. Ingestion pièce monnaie ($> 20\text{j}$)

1) **Gaviscon** sachet $1\text{sachet} \times 2/\text{j}$ après repas $\rightarrow 1\text{ bte}$

2) **Ultra lévure** sachet $1\text{sachet } 1^*/\text{j} \rightarrow 1\text{ bte}$

3) **Ezilax** sirop $1\text{càm } 2^*/\text{j} \rightarrow 1\text{ flc}$

VII. Ingestion caustique ($\text{ph} < 2$ ou > 12)

Problème majeure : risqué évolutif/sténose des lésions ($+++ > 3$ semaines).

ASP $+++$

- Selon Clinique/causticité

- Arrêt l'alimentation orale.

- Surveillance $+++$ (radiologique) : si normale :

Nobac sirop $1\text{càm} \times 2/\text{j} \rightarrow 1\text{ flc}$.

VIII. Abscess anal +/- collecté

1) **Augmentin** $80\text{mg}/\text{kg}/\text{j} \rightarrow \text{QSP } 10\text{j}$

2) **Doliprane** suppo/cp $1/6\text{h} \rightarrow 1\text{ bte}$ (Si fièvre ou douleur)

3) **Fucidine** pommade $1\text{app } 3^*/\text{j} \rightarrow 1\text{ flc}$

FORMES CLINIQUES

I. Grosse bourse

→ Brutale

- Douleur aigue < 2h < 6h : échographie avec doppler pour éliminer une torsion testiculaire → **trt chirurgical.**
- Progressif : évaluation, si pas d'urgence : échographie, peut être orchi-épididymite → **trt médical.**

II. Appendicite

Douleur abdominale (surtout FID +++), fébrile + sensibilité à la palpation → échographie si appendicite → bilan complet.

III. Invagination

- Age < 2ans.
 - Sd grippal
 - Cris incessants
 - Refus de tété
 - Douleur brutale
- Echographie : image en cocarde

IV. Ingestion pile bouton

Admission : ASP (localisation)

V. Occlusion

- AMG (+3jours) + AEG + vms + distension abdominale → ASP

VI. Ingestion du corps étranger

ASP : localisation :

- Si **œsophagienne** : enlever par la fibroscopie.
- Si **intestinale** : patienter 48-72h : rendez-vous 48-72h si non retirer.

VII. Hernie ombilicale/inguinale

→ Réductibilité :

- Oui : échographie.
- Non : solumédrol 1mg/kg → après 30min : réductible, si non → bloc chirurgical.
- Fille : opérer en urgence, la réductibilité est Cl.
- Garçon : on peut réduire.

LES ORDONNANCES DES URGENCES EN CCI

• Ordonnance pour brûlé

- 1) Clacial sirop 1 cam/j ----- → 1 flc
- 2) Ferrostrane sirop 1 cam * 2/j ----- → 1 flc
- 3) Astrox sirop 1 cam /j le soir ----- → 1 flc
- 4) Mebo pommade / Flammazine : les 2 sont types de Biafine.
- 5) Tulle gras.
- 6) Doliprane + Augmentin : à la sortie.
- 7) Bande vello.

• Hernie inguinale engorgée

- 1) Solumédrol 1 mg/kg IV : Pour faire une réduction.

On injecte solumédrol pour faire une réduction :

- En cas d'une hernie inguinale engorgée chez un **garçon** : après 30 mn, si la hernie reste irréductible donc considérer comme une urgence opératoire.
- En cas d'une hernie inguinale engorgée chez une **filles** : c'est une urgence opératoire, directement transférer au bloc opératoire.

NB : toujours vérifier d'abord que les testicules sont en place !

• Médicaments de CCI

- 1) Claforan (céfotaxim) : 100 mg/kg → résultat/ 3 = X : X * 3/j sans dépasser 3g/j, > 30 kg → 1g * 3/j.
- 2) Augmentin 100 mg/kg → résultat/ 3 = X : X * 3/j.
- 3) Flagyl 30 mg /kg → résultat/ 3 = X : X * 3/j **ou** 10 mg/kg * 3/j.
- 4) RDB : 100 ml/kg /24h sans dépasser 2 l/j.
- 5) Perfalgol : 15 mg/kg : A, A * 4/j.
- 6) Solumédrol 1mg/kg
- 7) Oroken (céphalosporine) sirop 8mg/kg * 2/j.

• Schéma de Carvajal : remplissage chez un brûlé

J1 : 2000*SC + (5000 * SB).

J2 : 1500*SC + (4000 * SB).

J3 : 2200*SC + (2800 * SB).

SC : $\frac{4 \text{ p} + 7}{\text{p} + 90}$ SB : $\frac{\text{Sc estimation}}{100} = \text{SC} * \text{X}\%$

SC : surface corporelle totale en m²

P : poids en kg.

SB : surface corporelle brûlée en m²

X% : 0.X

→ Albumine : poids * 5 = Q

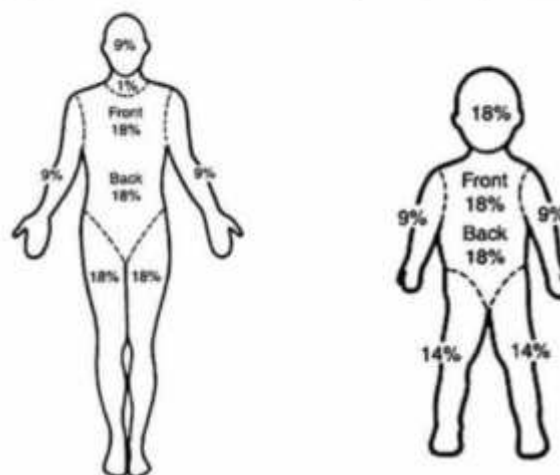
Dilution : 3Q * SG.

→ Pour l'Augmentin (à titre externe) :

si > 40 kg = 50 mg/kg/j * 3/j.

En général, ce schéma calcule par le résident.

Segment corporel	Surface atteinte	
	Adulte	Enfant
Tête et cou	9 %	17 %
Face antérieure du tronc	18 %	18%
Face postérieure du tronc	18 %	18%
Chaque jambe	18 %	14%
Chaque bras	9 %	9%
Périnée	1 %	1%
Total	100 %	100%



• RDB

RDB : SG 10% pendant 24h.

= 100 cc/kg pour le poids < 10kg

+ 50 cc/kg pour le poids entre 10 et 20 kg

+ 20 cc/kg pour le poids > 20kg.

Ex si poids 44kg

= 100*10 + 50*10 + 14*10 = 1640 ml.

RDB = 1640 ml (24 de G 10%).

• Avis CCI

Il s'agit de l'enfant Agé de Victime d'un accident de la circulation ce qui lui a engendré :

Chez qui l'examen clinique retrouve :

→ L'enfant éveillé, conscient, coopérant, EG conservé.

→ BCCM : bonne coloration cutané-méqueuse

→ BCHD : bon constantes hémodynamiques.

→ Thorax de morphologie normale sans point d'impact + ampliation thoracique symétrique.

• ACCIDENT DE LA VOIE PUBLIQUE ou de la circulation.

→ Rx de thorax

→ Rx de bassin

→ Si l'enfant est stable : échographie abdomino-pelvienne.

→ Descriptif si échographie sans anomalies.

• Médicaments (à titre externe)

- 1) Augmentin 50mg/kg/j * 3/j (qsp /j).

- 2) Oroken sirop enfant : 1 ddp*2/j (qsp/j)
 < 10kg : sirop 40mg (1 ddp*2/j).
 10 - 40kg : 100mg (1 ddp*2/j).
 >40kg : cp 200mg * 2/j.
- 3) Flagyl sirop 25mg (qsp 7j).
 100mg/kg/j.
 Si cp : 250 – 500mg.
- 4) Doliprane suppo : 1 bte
 < 8 : 100mg
 < 12 : 150 mg
 < 20 : 200 mg
 >20 : 300 mg
 Cp : 500mg – 1000mg.

Fiche à remplir après la circoncision

06/03/2018

Page 1/3

CHU DE SFR
SERVICE DE CHIRURGIE PEDIATRIQUE
Pr Z. SOUALLI
FICHE DE LA CIRCONCISION

Identification de l'enfant
Nom et Prénom: **BERNARD SIFOMOU**
Age: **03 ans 1**
Sex: **M**
Tél: **0697625058**
Adresse: **Mar. n. 2**

Examen clinique du prépuce et du pénis

Aspect photo: 

Longueur de la verge (la partie découverte d'émergence en décubitus dorsal): **24 cm**

Examen de la verge en position: normal

Normal: ☒
Balanoposth: ☐
Effort: ☐
Normal: ☒ Récidive: ☐ Scarre: ☐

Examen de la verge en position: déficient

Aspect du prépuce: long ☐
Moyen: ☒
Court: ☐

Vascularisation aux transflexions: importante ☒ Récurrente: ☐

Mobilité du méat: Oui ☒ Non ☐
Non ☐ → Rétraction facile (du prépuce): ☐
Agglutination diffuse: ☐

Assises du méat: un ☒ deux ☐ trois ☐
Quatre ☐

Forme et Caput: Oui ☒ Non ☐
Long: ☒ Court: ☐

Aspect du méat: ovale ☐
Long: ☒
Court: ☐

Aspect du méat: vertical ☒
Horizontal: ☐

Aspect du méat: droit ☒ Gauche ☐
Droite ☐ Gauche ☐

Aspect du méat: adhérent (en position normale) ou adhérent (en position normale) (indiquer au niveau du prépuce)

< 0.1 cm ☒
0.1 cm ☐
1 cm ☐
> 2 cm ☐

Aspect du prépuce: rétracté ☒ En place: ☒
Hypoplasique: ☐
Non palpable: ☐

Galerie: Symétrique ☒
Asymétrique: ☐
Pas de galerie: ☒
Pas de galerie: ☐

Présence de galerie au niveau du prépuce: Oui ☐ Non ☒

Verge couverte en position: verticale: Oui ☐ Non ☒

Assises méaires: Hypoplasie + cousture ☐
Hypoplasie + cousture + transposition ☐

Circumcision bilatérale: Oui ☐ Non ☒

Page 2/2

A. 1  

2  

3  

B. * temps total :  anethésie locale :  anethésie générale : 

* $\approx$ 45 min
 * 10min - 30min
 * 150 min

C. * nombre de points saturés :
 - face dorsale : 
 - face ventrale : 
 - côté gauche : 
 - face ventrale : 

D. Passerement :  Oui  Non 

virage à Corbière

E. * Avis de la famille :
 bien : 
 moyenne : 
 mauvais : 

F. * nécessité d'un contrôle :
 Oui : 
 Non : 

G. * nombre de saignées figuratives : 

H. * tests :
 réactif : 
 conservé : 

Merci de remplir correctement cette fiche
 Attention au numéro d'enregistrement